

간호대학생의 지각된 스트레스와 불안과의 관계에서 회복탄력성의 매개효과

조은희¹⁾

Mediating Effects of the Relationship of Perceived Stress and Anxiety with Resilience in Nursing Students

Eun Hee, Jo¹⁾

요 약

본 연구는 간호대학생의 지각된 스트레스, 불안, 회복탄력성 정도를 파악하고 이들 간의 관계를 파악하고자 시도된 서술적 조사연구이다. J도 3개 간호대학생을 대상으로 2018년 6월에서 8월까지 자료를 수집하였으며 최종적으로 209부를 분석하였다. SPSS 23.0 통계 프로그램을 이용하여 기술통계, t-test, ANOVA, 상관분석, 위계적 회귀분석, Sobel test 방법으로 분석하였다. 간호대학생의 지각된 스트레스는 불안과 정적상관관계를 나타냈으며 회복탄력성과는 부적상관관계를 나타냈다, 불안과 회복탄력성은 부적상관관계를 나타냈다. 매개효과의 통계적 유의성을 검증하기 위해 Sobel test를 실시한 결과 간호대학생의 지각된 스트레스가 불안과의 관계에서 회복탄력성이 매개되어 지각된 스트레스의 직접 효과도 통계적으로 유의하였고, 회복탄력성을 통한 간접 효과도 유의한 것으로 나타났다($Z=3.51$, $p<.001$). 따라서 간호대학생들에게 지각된 스트레스와 불안을 감소시킬 방안을 교육과정 안에 편성하여 체계적인 관리가 필요하다. 이와 더불어 회복탄력성을 증진하는 다양한 프로그램을 개발하여 간호대학생들에게 적용하고 그 효과를 검증하는 연구가 필요할 것이다.

핵심어: 간호대학생, 지각된 스트레스, 불안, 회복탄력성, 임상스트레스

Abstract

The aim of this study was to understand the relationship of perceived stress and anxiety with certain positive variables like resilience. The sample consisted of 209 nursing students who were in three different colleges in the J-province from June to August 2018. For the analysis of data, descriptive statistics, t-test, ANOVA, correlation analysis, and hierarchical regression analysis, sobel test were used by SPSS 23.0 program. The result obtained indicated that the nursing students' perceived stress static correlated with anxiety and correlated negatively with resilience. Anxiety indicated a negative correlation with resilience. Evidence showed that resilience can buffer the perceived stress and anxiety directly and indirectly($Z=3.51$, $p<.001$). Thus, Nursing students need to systematically manage the curriculum to reduce the perceived stress and anxiety. In addition, research is needed to develop various programs that promote resilience and apply

Received(August 3, 2019), Review Result(August 28, 2019)

Accepted(October 7, 2019), Published(October 31, 2019)

¹Assistant Professor, 54068, Dept. of Nursing, Kunsan College of Nursing, 7, Donggaejeong-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Korea

E-mail: almaz0920@kcn.ac.kr

ISSN: 2383-5281(Print) AJMAHS

ISSN: 2383-7268(Online) Copyright © 2019 HSST

them to nursing students and to verify their effectiveness.

Keywords: Nursing students, Perceived stress, Anxiety, Resilience, Clinical practice stress,

1. 서론

1.1 연구의 필요성

대학생은 성인으로 가는 과도기로 자아정체감을 확립하고 사회인이 되기 전 준비단계로 대학생 생활에의 적응, 미래에 대한 불안감, 진로 및 직업계획, 인간관계, 직업선택, 진로 및 취업준비로 인한 가장 스트레스가 많은 시기이다[1-2]. 간호대학생은 타 전공 대학생들에 비해 스트레스 높다고 알려져 있는데 그 이유는 전문지식 습득과 관련한 과중한 학업 량 뿐 아니라 임상실습을 병행해야 하기 때문에 학교이외의 공간인 병원이라는 특수상황에 대한 또 다른 스트레스를 경험하게 된다[3-4].

간호대학생은 교과 과정 중 임상실습은 필수 요건이기 때문에 이로 인하여 임상현장에서 직접 경험하는 환자의 고통이나 죽음, 실수나 환자에게 해를 끼치는 것에 대한 두려움, 지식과 임상술기의 부족, 평가에 대한 불안감, 임상현장에서의 간호사와의 관계의 어려움 등 다양한 임상실습으로 인하여 스트레스를 경험하게 된다[3-5]. 스트레스는 효과적으로 대응하지 못하면 긴장, 불안 등의 심리적 장애를 초래할 뿐 아니라 학업부진 등과 같은 행동장애, 두통 등과 같은 신체적 증상 까지 발생할 수 있다[6].

특히, 간호대학생의 스트레스는 의과대학생의 스트레스보다도 훨씬 더 높다고 하였는데, 이러한 높은 스트레스에 노출된 간호대학생들에게 스트레스에 대한 적절한 중재가 이루어지지 않으면, 정신적인 건강문제 중 하나인 불안증상이 나타나게 된다[7-8].

스트레스의 적응 기전으로 오는 불안은 위험한 상황이나 위협을 인지했을 때 나타나는 정서 반응으로 의욕과 성취동기를 감소시키며, 불안이 심할수록 적응에 방해 요소로 작용하여 개인의 인격형성과 발달 뿐 아니라 인간관계에 장애 요인으로 개인의 생활에 영향을 준다[9]. 이러한 부정적 정신적 건강문제인 불안은 학업 뿐 아니라 임상 실습에 있어 방해요인으로 불안은 우울과 밀접한 상관관계가 가장 높은 정신적 건강 문제이다[10-11].

회복탄력성은 어려움을 해결하고 스트레스 상황에 직면했을 때 이겨낼 수 있는 잠재적인 능력으로 정상적인 상태로 되돌아올 수 있는 정신적인 저항력으로 스트레스를 완화 시키고 성공적으로 적응하는 내적힘이다[12]. 회복탄력성이 높으면 대학 생활에 대한 적응도 높아진다고 하였는데 대학 생활 부적응 문제를 완화할 수 있고, 어려움을 극복하는데 긍정적이고 능동적인 조절능력으로서 회복탄력성이 필요하다고 하였다[13].

회복탄력성은 예비간호사인 간호대학생들에게 심리적인 안정감을 주어 성숙한 간호사로 성장하는데 도움을 주는 중요한 요소로, 스트레스를 유발하는 환경에 유연하게 대응하는 개인의 총체적인 내적 능력이며 인생의 역경을 이겨내는 힘이며, 스트레스를 겪은 후 원래대로 회복시킬 수

있는 심리적 회복능력으로 문제를 기대 이상으로 극복하여 더 나은 삶을 살 수 있게 하는 능력이다[14-15].

간호대학생을 대상으로 회복탄력성과 관련된 논문을 살펴보면 회복탄력성이 높은 사람이 스트레스 관리와 대학생활적응을 잘 하는 것으로 나타났으며[16], 회복탄력성이 높은 간호대학생은 전공과 실습만족도 및 임상수행능력이 높았다고 하였지만[17], 간호대학생의 지각된 스트레스와 불안과의 관계에서 회복탄력성이 어떠한 영향을 미치는지에 대해 매개효과를 분석한 연구는 미비한 실정이다.

따라서 간호대학생을 대상으로 지각된 스트레스가 불안에 영향을 미치는 경로에서 회복탄력성의 매개효과를 규명함으로써 지각된 스트레스와 불안에 취약한 간호대학생의 스트레스 관리와 불안 예방을 위한 예방 프로그램 개발에 기초자료를 제공하고자 한다.

1.2 연구문제

본 연구의 목적은 간호대학생의 지각된 스트레스와 불안과의 관계에서 회복탄력성의 매개효과를 규명하기 위함이며, 이를 위한 구체적인 목적은 다음과 같다.

첫째, 간호대학생의 일반적 특성과 지각된 스트레스, 불안과 회복탄력성의 차이를 파악한다.

둘째, 간호대학생의 지각된 스트레스, 불안과 회복탄력성과의 상관관계를 확인한다.

셋째, 간호대학생의 지각된 스트레스, 불안과의 관계에서 회복탄력성의 매개효과를 확인한다.

2. 연구방법

2.1 연구대상

본 연구는 간호대학생의 지각된 스트레스와 불안의 관계에서 회복탄력성의 매개효과를 확인하기 위한 서술적 조사연구이다. 연구대상자는 K도 소재의 3개 간호대학에 재학 중인 만 19세 이상의 간호대학생을 임의 표출하였다. 본 연구의 대상자수는 G power 3.1.9.2 프로그램을 이용하여 다중회귀분석을 위해 유의수준 .05, 검정력 .90, 중간 효과 크기 .15, 예측변수 2개를 기준으로 하였을 때 필요한 최소 표본수는 107명으로 산출되었다. 본 연구에서는 탈락률을 고려하여 총 220부를 배부하였으며 응답한 자료 중 불성실한 설문 11부를 제외하고 총 209부를 최종분석에 사용하였다.

2.2 연구도구

2.2.1 지각된 스트레스

본 연구는 지각된 스트레스를 측정하기 위해 Cohen, Kamarck 및 Mermelstein[18]이 개발한 측정도구를 Lee[19]가 번안한 도구를 사용하였다. 지난 한 달 간 개인의 생활이 예측할 수 없고, 조절할 수 없으며, 부담이 되었다고 지각하는 정도를 의미한다. 본 도구는 10개 문항, 5점 척도로 구성되었다. Lee[10]의 연구에서는 Cronbach's alpha값은 0.74이었고, 본 연구에서 Cronbach's alpha값은 .85이었다.

2.2.2 불안

본 연구는 불안을 측정하기 위해 Spielberger, Gorsuch와 Lushene[20]의 State-Trait Anxiety Inventory를 Kim과 Shin[21]이 표준화한 도구 중에서 상태불안척도 도구를 사용하였다. 상태불안은 총 20문항으로 염려, 긴장, 초조, 걱정 등에 대해 지금 이 순간에 바로 느끼고 있는 상태를 측정하는 것으로, 10개의 긍정문항과 10개의 부정 문항, 4점 척도로 구성되었다. Kim과 Sin[21]의 연구에서 상태불안의 Cronbach's alpha값은 .87이었고, 본 연구에서 Cronbach's alpha값은 .93이었다.

2.2.3 회복탄력성

본 연구는 회복탄력성을 측정하기 위해 Reivich와 Shatté[22]가 성인을 대상으로 개발한 회복탄력성 지수검사(Resilience Quotient Test: RQT)를 Kim[14]이 번안하고, 한국인에 맞게 개발한 한국형회복탄력성지수(KQR-53) 도구를 사용하였다. 자기조절능력, 대인관계능력, 긍정정성으로 구성된 총 53문항, 5점 척도로 구성되었다. 동일 측정 도구를 사용한 Choi와 Seok[23]의 연구에서 Cronbach's alpha값은 .93이었고, 본 연구에서 Cronbach's alpha값은 .86이었다.

2.3 자료수집 방법

본 연구는 2018년 6월에서 8월까지 자료를 수집하였으며, 해당 대학의 간호학과장과 담당교수에게 연구목적을 설명한 후 협조를 구하였다. 설문지 작성 전에 연구 목적 등을 설명한 후 자발적으로 참여에 동의한 사람에 한하여 설문지를 실시하였으며 설문지 작성은 자기기입식으로 진행되었다.

2.4 윤리적 고려

연구대상자의 윤리적 측면을 고려하여 연구의 목적, 비밀보장, 자발적 참여와 익명성에 대해 상세히 구두로 설명한 후, 연구 설명문과 동의서를 제공하여 자필 서명을 받았다. 연구 참여에 동의한 후에도 언제든지 연구 참여를 철회 할 수 있으며 이로 인한 어떠한 불이익도 없음을 설명하였다. 연구대상자와 관련된 모든 자료는 연구용으로만 사용할 것이며 연구 설문지는 논문이 완성된 후 학회지에 출간 후 폐기할 것을 약속하였다. 연구대상자에게 참여에 대한 소정의 답례품을 제공하였다.

2.5 자료 분석 방법

수집한 자료는 SPSS/WIN 23.0 프로그램을 이용하여 다음과 같이 분석하였다.

첫째, 간호대학생의 일반적 특성은 실수와 백분율, 평균과 표준편차로 분석하였다. 일반적 특성에 따른 지각된 스트레스, 불안, 회복탄력성차이는 t-test와 ANOVA를 이용하여 비교하였다.

둘째, 간호대학생의 지각된 스트레스, 불안, 회복탄력성 정도는 평균과 표준편차로 분석하였다.

셋째, 간호대학생의 지각된 스트레스, 불안, 회복탄력성과의 상관관계는 Pearson's correlation coefficients로 분석하였다.

넷째, 간호대학생의 지각된 스트레스와 불안과의 관계에서 회복탄력성의 매개효과를 확인하기 위해 Baron과Kenny[23]가 제시한 절차에 따라 3단계 회귀분석을 실시였다. 1단계로 독립변수와 매개변수와의 회귀분석, 2단계로 독립변수와 종속변수와의 회귀분석, 그리고 3단계로 독립변수, 매개변수 모두와 종속변수와의 회귀분석을 실시하였고, 매개변수가 종속변수에 유의한 영향을 미치고 종속변수에 대한 독립변수의 영향이 2단계 회귀분석보다 3단계 회귀분석에서 감소되었는지 확인하였다. 간호대학생의 지각된 스트레스가 불안과의 관계에서 회복탄력성의 매개효과 유의성을 검증하기 위해 Sobel test를 실시하였다.

3. 연구결과

3.1 대상자의 일반적 특성과 지각된 스트레스, 불안, 회복탄력성의 차이

대상자의 일반적 특성과 지각된 스트레스, 불안, 회복탄력성의 차이는 [표 1]과 같다.

성별은 여성이 166명(79.4%)으로 남성 43명(20.6%)보다 많았고, 학년은 2학년이 65명(31.1%)으로 가장 많았으며, 종교는 없음이 109명(52.2%)으로 있음 100명(47.8%)보다 많았다. 친한 친구는 없음이 100명(47.8%)으로 있음 67명(32.1%)보다 많았고, 흡연은 안 피움이 189명(90.3%)으로 많았으며, 음주는 하고 있음 145명(69.4%)이 많았다. 카페인섭취는 안함 101명(72.7%)이 가장 많았으며, 1잔 57명(27.3%), 2잔 26명(12.4%), 3잔 이상 14명(6.7%)순이었으며, 수면시간은 6시간 이하가 152명(72.7%), 6시간이상 57명(27.3%)보다 많았다.

대상자의 일반적 특성과 지각된 스트레스, 불안, 회복탄력성 정도는 대부분 통계적으로 유의한 차이가 없었으나 지각된 스트레스에서 친한 친구($t=.72$ $p=.002$), 수면시간($t=.33$ $p=.018$)에서 유의한 차이가 있었고, 불안에서 종교($t=1.76$ $p<.001$), 친한 친구($t=1.55$ $p=.043$)에서 유의한 차이가 있었다.

3.2 대상자의 지각된 스트레스, 불안과 회복탄력성 정도와 상관관계

대상자의 지각된 스트레스는 평균 1.78 ± 0.49 점(1-4점 척도), 불안은 평균 2.27 ± 0.46 점(0-4척도), 회복탄력성은 3.00 ± 0.36 점(1-5점 척도)으로 나타났다[표 2].

대상자의 지각된 스트레스는 불안($r=.707$, $p<.001$)과 정적상관관계, 회복탄력성($r=.359$, $p<.001$)과 부적상관관계를 나타냈으며, 불안은 회복탄력성($r=-.402$, $p<.001$)과 부적상관관계를 나타냈다[표 3].

[표 2] 지각된 스트레스, 불안, 회복탄력성과의 평균값

[Table 2] Descriptive Statistics among Perceived, Anxiety and Resilience (N=209)

변수	M $\pm$ SD	Min	Max	Range
지각된 스트레스	1.78 $\pm$ 0.49	1.00	3.94	1-4
불안	2.27 $\pm$ 0.46	1.00	3.20	0-4
회복탄력성	3.00 $\pm$ 0.36	1.21	3.94	1-5

[표 3] 지각된 스트레스, 불안, 회복탄력성과의 상관관계

[Table 3] The Relationship among Perceived Stress, Anxiety and Resilience (N=209)

변수	지각된 스트레스	불안	회복탄력성
	r(p)	r(p)	r(p)
지각된 스트레스	1		
불안	.707(<.001)	1	
회복탄력성	-.359(<.001)	-.402(<.001)	1

3.3 대상자의 지각된 스트레스와 불안과의 관계에서 회복탄력성의 매개효과

간호대학생의 스트레스와 회복탄력성과의 관계에서 회복탄력성의 매개효과를 확인하기 위해 Baron과 Kenny가 제시한 절차에 따라 3단계 회귀분석을 실시하였으며, 매개효과의 통계적 유의성을 검증하기 위해 Sobel test를 실시하였다. 회귀분석을 시행하기 위해 확인해야할 기본 가정 중 다중공선성을 확인한 결과 공차한계가 모두 1.0이하로 나타났고, 분산팽창인자는 기준인 10을 넘지 않아서 다중공선성의 문제는 없는 것으로 확인되었다. Baron과 Kenny가 제시한 방법에 따라 3단계 회귀분석을 실시하였다.

1단계에서 독립변수인 지각된 스트레스가 매개변수인 회복탄력성에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났으며($\beta=-1.29$, $p<.001$), 2단계에서도 독립변수인 지각된 스트레스가 종속변수인 불안에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다($\beta=1.40$, $p<.001$). 마지막으로 3단계에서 매개변수인 회복탄력성과 종속변수인 불안에 미치는 영향을 검증하기 위한 회귀분석을 실시한 결과 회복탄력성은 불안에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다($\beta=-.09$, $p=.001$).

따라서 회복탄력성을 통제한 상태에서 지각된 스트레스는 불안에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다($\beta=1.28$, $p<.001$). 본 연구결과를 토대로 매개변수인 회복탄력성의 투입으로 독립변수인 지각된 스트레스가 불안을 미치는 영향정도가 변화되었으므로 두 변수의 관계에서 회복탄력성은

매개효과를 보이는 것으로 확인되었다.

매개효과의 통계적 유의성을 검증하기 위해 Sobel test를 실시한 결과 간호대학생의 지각된 스트레스가 불안과의 관계에서 회복탄력성이 매개되어 지각된 스트레스의 직접 효과도 유의하였고, 회복탄력성을 통한 간접 효과도 통계적으로 유의한 것으로 나타났다($Z=3.51$, $p<.001$)[표 4].

[표 4] 지각된 스트레스와 불안과의 관계에서 회복탄력성의 매개효과

[Table 4] Mediating Effect of Resilience on the Relationship Between perceived Stress and Anxiety (N=209)

변수	β	t(p)	Adj. R2	F(p)	Sobel test
					z (p)
1. 지각된 스트레스 → 회복탄력성	-1.29	-5.53(<.001)	.13	30.58((<.001))	3.51.(<.001)
2. 지각된 스트레스 → 불안	1.04	1.40(<.001)	.50	207.21(<.001)	
3-1. 회복탄력성 → 불안	-.09	-3.32(.001)	.53	114.12(<.001)	
3-2. 지각된 스트레스 → 불안	1.28	12.57(<.001)			

[표 5] 대상자의 특성과 다른 변수와의 차이

[Table 5] Differences between Variables by General Characteristics

(N=209)

특성	구분		지각된 스트레스		불안		회복탄력성	
		n(%)	Mean±SD	t/F(p)	Mean±SD	t/F(p)	Mean±SD	t/F(p)
성별	남	43(20.6)	17.07±5.09	-1.39(.860)	46.51±11.39	-.63(.097)	154.28±15.87	2.85(.994)
	여	166(79.4)	18.23±4.82		47.55±9.22		146.86±17.62	
학년	1학년	42(20.1)	17.40±4.59	1.01(.390)	46.50±9.57	2.14(.096)	143.79±18.09	1.23(.301)
	2학년	65(31.1)	17.89±4.89		47.46±9.79		146.68±20.33	
	3학년	60(28.7)	18.86±5.31		49.55±9.40		149.78±15.92	
	4학년	42(20.1)	17.99±4.88		44.81±9.64		149.67±14.21	
종료	있음	100(47.8)	17.10±5.01	2.56(.230)	46.11±10.84	1.76(.001)	149.93±15.24	-1.86(.258)
	없음	109(52.2)	18.10±5.01		48.46±9.26		145.44±19.29	
친한 친구	있음	67(32.1)	16.47±6.55	.72(.006)	46.63±10.21	1.55(.043)	144.76±13.11	-1.60(.090)
	없음	109(52.2)	17.61±4.88		48.84±8.344		148.92±19.22	
흡연	하고 있음	20(9.6)	17.35±5.07	-.62(.767)	48.25±7.43	.44(.167)	148.55±11.16	.26(.394)
	안함	189(90.4)	18.06±4.88		47.24±9.90		147.49±18.14	
음주	하고 있음	145(69.4)	17.87±5.10	-.54(.168)	47.30±9.42	-.09(.157)	146.97±18.79	-.76(.358)
	안함	64(30.6)	8.26±4.41		47.42±10.34		148.98±14.49	
카페인섭취	안함	101(72.7)	18.89±4.96	2.65(.051)	47.11±9.12	.47(.701)	144.32±17.61	2.52(.059)
	1잔	57(27.3)	17.16±4.89		46.79±10.66		150.56±19.01	
	2잔	26(12.4)	17.73±4.85		49.35±10.24		152.39±14.26	
	3잔 이상	14(6.7)	16.00±4.49		47.34±9.68		146.86±11.31	
수면시간	6시간 이하	152(72.7)	18.06±5.20	.33(.018)	41.26±8.66	.35(.853)	145.97±17.81	-2.20(.850)
	6시간 이상	57(27.3)	17.81±3.97		40.79±8.61		151.91±16.30	

4. 논의

본 연구는 간호대학생의 지각된 스트레스가 불안에 미치는 영향에서 회복탄력성의 매개효과를 규명하고자 연구를 수행하였으며, 주요 연구결과를 중심으로 논의하고자 한다.

일반적 특성에 따른 지각된 스트레스에서는 친한 친구와 수면시간에서 유의한 차이가 있었으며, 불안에서는 종교와 친한 친구에서 유의한 차이가 있었다. 선행연구인 홍은영(2014)의 연구결과와 마찬가지로 친한 친구가 없는 경우 지각된 스트레스와 불안점수가 높게 나타났다[24]. 이는 같은 고민을 하고, 같은 생각을 하는 비슷한 또래의 지지체계가 스트레스와 불안을 감소시키는 요인으로 동질감이 형성되기 때문으로 사료된다. 종교가 없는 대상자가 불안 점수가 높게 나타났는데 이는 종교생활을 하면서 다양한 사람들과 접촉할 수 있는 기회와 정신적인 지지체계가 형성되어 있기 때문으로 사료되며, 수면시간에서는 6시간 이하로 수면을 취하는 대상자가 지각된 스트레스 점수가 높게 나타났는데 이는 강승걸 외(2002)의 연구와 마찬가지로 결과는 수면은 휴식과 활동의 생체리듬을 배경으로 수면은 정신건강문제 뿐 아니라 육체적인 건강문제에도 영향을 미치는 요인임을 알 수 있다[25].

지각된 스트레스의 평균 점수는 1.78 ± 0.49 점, 불안의 평균점수는 2.27 ± 0.46 점, 회복탄력성의 평균 점수는 3.00 ± 0.36 점으로 나타났다. 지각된 스트레스와 불안을 측정하기 위해서 같은 도구를 사용한 이윤경과 김현리(2014)의 연구결과에서는 지각된 스트레스 평균점수는 2.55 ± 0.55 점, 불안 평균점수는 2.26 ± 0.70 점으로 본 연구결과와 지각된 스트레스 평균점수 1.78 ± 0.49 점 보다는 높았으며, 불안 평균점수 3.00 ± 0.36 보다는 낮게 나타났지만 본 연구결과와 크게 차이가 나지 않은 결과를 나타냈다[26]. 이는 간호대학생은 수업과 실습을 병행해야하는 상황에 대해 간호학과에 입학 시부터 지속적인 설명을 통하여 이미 알고 있는 상황이지만, 막상 3학년부터 임상실습을 통한 실무를 경험하고, 그로 인한 대인관계 및 의사소통을 해야 하는 부담감, 짧은 기간 동안 수업, 실습, 시험을 병행해야 하는 위치에 있기 때문에 불안감이 높아질 수 있을 것이다.

간호대학생의 지각된 스트레스는 불안과의 관계에서 정적상관관계($r=.707$, $p<0.001$)를 나타냈으며, 회복탄력성과는 부적상관관계($r=-.359$, $p<0.001$)를 나타냈고 불안은 회복탄력성에서 부적상관관계($r=-.402$, $p<0.001$)를 나타냈는데, 본 연구결과는 선행연구결과와 일치하는데[26-27], 이는 지각된 스트레스가 높을수록 불안 증상이 더 가중되지만 회복탄력성이 높은 사람일수록 스트레스 상황에서 본인의 본연의 긍정적인 측면을 활용하여 정서를 조절하면서 스트레스나 불안과 같은 심리적인 부분을 조절하는 측면이라고 볼 수 있다. 이와 같이 회복탄력성은 지각된 스트레스와 불안을 감소시키는 중요한 변인이며 불안은 내적갈등과 욕구가 현실적인 상황에서 충족되지 않을 때 발생하는 현상으로 개인이 현실에 적응하고 어떤 어려운 상황에 처해있을 때 회복탄력성은 이를 해결할 수 있는 긍정적인 요소로 작용하기 때문에 불안한 학생을 조기에 발견하고 대처할 수 있는 상담체계 강화와 동시에 회복탄력성을 증진하는 맞춤형 프로그램을 접목하면 그 효과가 더 증가할 수 있으

리라 사료된다.

지각된 스트레스와 불안과의 관계에서 회복탄력성의 매개효과를 검증한 결과, 불안에 대한 스트레스의 β 값이 2단계의 결과보다 수치가 감소하였다. 즉 매개변수인 회복탄력성의 투입으로 독립변수인 지각된 스트레스가 불안을 미치는 영향정도가 변화되었으므로 두 변수의 관계에서 회복탄력성은 매개효과를 보이는 것으로, 선행연구결과와 일치함을 알 수 있다[28]. 회복탄력성은 살아가면서 본인의 의지로 지속적으로 학습되고 발달될 가능성이 있는 가변적인 특징으로 간호사가 되기 위한 과정인 간호대학생을 관리하기 위한 필수적인 요소라고 볼 수 있다고 하였다[29]. 임상간호사의 우울, 스트레스, 분노가 일반 여성보다 현저히 높다는 연구결과[30]들이 많이 나오고 있는 상태에서 취업의 문은 넓으나 취업 후 이직을 감소시키기 위해서는 회복탄력성의 기본 구성요소인[15], 자아존중감을 향상시키고 자기조절능력을 향상시키고, 긍정성을 강화시키기 위해서는 간호대학생 때부터 회복탄력성을 증진시킬 필요가 있다. 따라서 지각된 스트레스와 불안을 감소시키기 위한 체계구축과 더불어 지각된 스트레스와 불안감소를 위한 매개효과가 있는 회복탄력성을 증진시키기 위한 포괄적 건강관리 프로그램을 단계적으로 개발하여 예비 간호사가 되어야 할 간호대학생들을 위한 관리는 필수적이라고 할 수 있을 것이다.

5. 결론 및 제언

본 연구는 간호대학생의 지각된 스트레스가 불안에 미치는 영향에서 회복탄력성의 매개효과를 규명하고자 연구를 시행하였다. 연구결과 간호대학생의 지각된 스트레스는 불안과의 관계에서 정적상관관계를 나타냈고, 회복탄력성과는 부적상관관계를 나타냈으며, 불안은 회복탄력성과의 관계에서 부적상관관계를 나타냈다. 간호대학생의 지각된 스트레스와 불안에 영향을 주는 회복탄력성은 매개효과가 있는 것으로 확인되었다.

본 연구결과 예비간호사가 될 간호대학생들의 지각된 스트레스와 불안 정도를 확인하여 이를 조절하고 관리할 수 있는 하나의 방안으로 회복탄력성이 효과가 있는 것으로 검증되었다. 따라서 간호대학생들에게 지각된 스트레스와 불안을 감소시킬 방안을 교육과정 안에 편성하여 체계적인 관리를 할 필요가 있으며, 이와 더불어 회복탄력성을 증진하는 다양한 프로그램을 개발하여 간호대학생들에게 적용하고 그 효과를 검증하는 연구가 필요하다.

References

- [1] S. H. Lee and S. J. Kim, The degree of perceived stress, depression and self Esteem of university students. *Journal of Korean Public Health Nursing*. (2012), Vol.26, No.3, pp.453-464.
- [2] D. Sarokhani, A. Delpisheh, Y. Veisani, M. T. Sarokhani, R. E. Manesh, and K. Sayehmiri, Prevalence of depression among university students: A systematic review and meta-analysis study. *Depression Research and Treatment*. (2013), pp.1-7.
- [3] P. Burnard, D. Edwards, K. Bennett, V. Tothova, D. Baldacchino, P. Bara and J. Myteveli, A comparative, longitudinal study of stress in student nurses in five countries: Albania, Brunei, the Czech Republic, Malta and Wales. *Nurse Education Today*. (2008), Vol.28, No.2, pp.134-145.
- [4] S. K. Cha and E. M. Lee, Comparison of stress, depression and suicidal ideation between nursing students and students of other majors. *Journal of Korean Academic Society of Nursing Education*. (2014), Vol.20, No.4, pp.650-658.
- [5] H. R. Hakojärvi, L. Salminen and R. Suhonen, Health care students' personal experiences and coping with bullying in clinical training. *Nurse education today*. (2014), Vol.34, No.1, pp.138-144.
- [6] K. Yang, K. S. Han, M. H. Bae and S. H. Yang, Social support, academic stress, clinical practice stress in college student of nursing. *The Korean journal of stress research*. (2014), Vol.22, No.1, pp.23-33.
- [7] M. C. Jones and D. W. Johnston, Distress, stress and coping in first year student nurses. *Journal of Advanced Nursing*. (1997), Vol.26, No.3, pp.475-482.
- [8] N. Shiaki, M. Shono and T. Kitamura, Effects of coping styles and stressful life events on depression and anxiety in Japanese nursing students: A longitudinal study. *International Journal of Nursing Practice*. (2009), Vol.15, No.3, pp.198-204.
- [9] B. G. You, An effect of stress, self-esteem on college students' anxiety. *Korean Journal of Counseling & Psychotherapy*, (2010), Vol.1, No.21 pp.33-34.
- [10] S. Y. Han and Y. M. Lee, The relationship between anxiety, anger and fatigue among stress factor of nursing students in clinical practice. *Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society*. (2012), Vol.13, No.2, pp.554-561.
- [11] K. S. Han, E. S. Park, J. A. Song, K. M. Kim, J. H. Jin and H. C. Kang, Interpersonal attachment style, emotional regulation, and symptoms of stress, among university students. *Journal of Korean Academy of Psychiatric and Mental Health Nursing*. (2007), Vol.16, No.16, pp.198-204.
- [12] B. Leipold and W. Greve, Resilience: A conceptual bridge between coping and development. *European Psychologist*. (2009), Vol.14, No.1, pp.40-50.
- [13] J. A. Kim, The Effects of Resilience on Adjustment to College and Career Barriers of College Students Majoring in Secretarial Studies. *Journal of Secretarial Studies*. (2016), Vol.25, No.1, pp.161-183.
- [14] J. H. Kim, *Resilience*. Seoul: Wisdomhouse. (2011), pp.250-255
- [15] J. E. Brooks, Strengthening resilience in children and youths: Maximizing opportunities through the schools. *Children & Schools*, (2006), Vol.28, No.2, pp.69-76.

- [16] H. S. Hong and H. Y. Kim, Effect of academic stress, clinical practice stress, resilience on nursing student's adjustment to college life. *Asia-Pacific Journal of Multimedia Service Convergent with Art, Humanities, and Sociology*, (2016), Vol.6, No.2, pp.221-23.
- [17] D-J. Kim, and J-S. Lee, Influence of Ego-Resilience and Self-Efficacy on Satisfaction in Major of Nursing Student. *The Journal of Korean Academic Society of Nursing Education*. (2014), Vol.20, No.2, pp.244-254. 2014.
- [18] S. Cohen, T. Kamarck and R. Mermelsteine, A global measure of perceived stress. *Journal of Health and Social Behavior*. (1983), Vol. 24, No.4, pp.385-396.
- [19] Y. M. Lee, Effect of self-foot reflexology massage on depression, stress responses and immune functions of middle aged women. *Journal of Korean Academy of Nursing*. (2006), Vol.36, No.1, pp.179-188.
- [20] C. D. Spielberger, STAI manual for the state-trait anxiety inventory. *Self-Evaluation Questionnaire*. (1970), pp.1-24.
- [21] J. T. Kim and D. K. Shin, A study based on the standardization of the STAI for Korea. *Recent Medicine*. (1978), Vol.21, No.11, pp.69-75.
- [22] K. Reivich and A. Shatté, *The resilience factor*. New York: Broadway Books. (2003).
- [23]. H. J. Choi and E. J. Seok, "An analysis of child care teachers" resilience and job satisfaction", *Korea Journal of Child Care and Education*, (2013), Vol.17, pp.93-115.
- [24] Y. Hong, The Mediating Effect of Humor on the Relationship between Perceived Stress and Depression in College Students. *The Journal of Korean Academic Society of Nursing Education*. (2014), vol.20, No4, 558-568.
- [25] S. G. Kang, H. K. Yoon, B. J. Ham, Y. K. Choi, S. H. Kim, S. H. Joe, Y. S. Kwang and L. Kim, Effects of Minor Stressful Events on Sleep in College Students. *Sleep medicine and psychophysiology*. (2002), Vol.9, No1, pp.48-55.
- [26] Y. K. Lee and L. H. Kim, The relationship of ego resilience and involvement with the experience of anxiety and perceived stress in nursing students. *Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society*. (2014), vol.15, No.4, pp.1953-1962.
- [27] M. M. Tugade and B. L. Fredrickson, "Resilience individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences". *Journal of Personality and Social Psychology*. (2004), Vol.86, No.2, pp.320-333.
- [28] S. H. Choi, and H. Lee, Influence on College Students Depression of Anxiety, Unemployment Stress, and Self-esteem-Moderating Effect of Resilience. *The Journal of the Korea Contents Association*, (2014), Vol.14, No.10, pp.619-627.
- [29] K. H. Kim and H. J. Ju, The Effects of Children Resilience on Social Problem-Solving Ability and Psychosocial Adjustment. *Journal of Korean Council for Children & Rights*. (2013), Vol.17, No.3, pp.437-457,
- [30] W. H. Lee, C-J. Kim, The Relationship between Depression, Perceived Stress, Fatigue and Anger in Clinical Nurses. *Journal of Korean Academy of Nursing*, (2006). Vol.36, No.6, pp.925-932